

УДК: 618.14-006.6

Н.Н. Мезинова

Центральная городская клиническая больница г.Алматы

## Рак тела матки. Настоящее и прошлое

*Аннотация. Цель исследования - изучить возможные причины роста заболеваемости раком тела матки.*

*Материалы и методы: материалами служили 34 больные раком тела матки, поступивших с маточным кровотечением в ЦГКБ в 2007-2011годы и 32 больные раком тела матки, прооперированных в КазНИИОиР в 1965-1969 годы.*

*Методы исследования: клинические, лабораторные, статистические. У всех больных диагноз верифицирован морфологическим исследованием соскоба эндометрия или удаленной опухоли. Степень ожирения определялась по ИМТ. Ожирение III степени определялось при ИМТ больше 40. Полученные данные подвергнуты статистической обработке, достоверность различий между сравниваемыми группами оценивалась по критериям Стьюдента. Различия между показателями считались достоверными при  $P \leq 0,05$ .*

*Установлено, что возраст современных менопаузальных больных достоверно выше, чем 40 лет назад. Современные больные раком тела матки достоверно чаще, чем 40 лет назад, позже вступают в менопаузу, меньше рожают. Рак чаще выявляется в миоматозно-измененной матке. Наблюдается тенденция к увеличению эндокринно-обменных заболеваний - ожирения, сахарного диабета 2 типа, артериальной гипертензией, чаще выявляется ожирение III степени.*

*Полученные данные свидетельствуют в пользу влияния старения организма и эндокринно – обменных заболеваний на рост заболеваемости раком тела матки.*

В последнее десятилетие отмечается рост заболеваемости раком тела матки (РТМ). Во многих странах РТМ занял первое место среди злокачественных опухолей половых органов. Предполагается, что причиной учащения РТМ может быть увеличение продолжительности жизни, эндокринно-обменных заболеваний, применение заместительной гормонотерапии в постменопаузе (Бохман Я.В., 1989; Вишневская Е.Е., 1989; Гинекология по Эмилю Новаку, 2002)[1,2,3].

### Цель исследования

- сравнение ряда клинических параметров больных РТМ, обследованных в 2007-2011гг. и в 1965-1969гг.

### Материалы и методы

Проведено обследование 66 больных РТМ. У 34 РТМ был диагностирован в ЦГКБ г. Алматы, куда женщины поступали с маточным кровотечением и при морфологическом исследовании соскоба слизистой матки установлено наличие аденокарциномы. Все препараты консультированы в городском онкологическом диспансере, куда

больные поступали для лечения. 32 больные являлись пациентками Казахского научно-исследовательского института онкологии и радиологии в 1965-1969 г.г., где они получали лечение по поводу РТМ [6]. Исходное клинико-лабораторное обследование включало: сбор анамнеза, общеклиническое исследование, изучение антропометрических данных. Степень ожирения определялась по индексу массы тела. При ИМТ 25-29,9 - диагностировалась избыточная масса тела, при ИМТ - 30-34,9 кг/м<sup>2</sup> - 1 степень ожирения, при ИМТ - 35-39,9 кг/м<sup>2</sup> - 2 степень ожирения, при ИМТ 40 и более кг/м<sup>2</sup> 3 степень ожирения. Наличие артериальной гипертензии и клинического сахарного диабета 2 типа - по заключению терапевта, эндокринолога, у которых больные находились на диспансерном учете, а также терапевтов тех учреждений, куда больные были госпитализированы. У пациенток КазНИИОиР, с научными целями проводился тест на толерантность к глюкозе для выявления латентного диабета. В виду того, что в ЦГКБ такой тест не проводился, учтены только больные с наличием клинического СД 2 типа. Больным, которые госпитализировались в ЦГКБ, производилось трансвагинальное ультразвуковое сканирование, оценивались размеры и структура М-ЭХО, матки и яичников. В 1965-1969гг. больные УЗИ не подвергались, и наличие миомы выявлялось при гинекологическом исследовании и по заключению морфологов, исследовавших экстирпированную матку. Достоверность различий клинико-лабораторными показателями в сравниваемых группах оценивалось по критериям Стьюдента. Различия между клинико-лабораторными показателями считались достоверными при  $p \leq 0,05$ .

### Результаты исследования и их обсуждение

Клиническая характеристика больных РТМ представлена в таблице. Первую группу составили 34 больных РТМ, который диагностирован в 2007-2011гг., вторую -32 больных РТМ, диагностированного в 1965-1969гг. Из таблицы следует, что в обеих группах больных преобладают женщины в постменопаузе. Ни одна постменопаузальная больная не получала заместительную гормонотерапию.

РТМ у женщин до наступления менопаузы составил в первой группе 26,5%, во второй- 15,6%. Средний возраст доменопаузальных больных первой группы был меньше, чем второй ( $47,3 \pm 1,5$  против  $52,0 \pm 2,9$  лет). Особого внимания заслуживает, тот факт, что у доменопаузальных пациенток обеих групп в течение длительного времени имели место маточные кровотечения, по поводу которых неоднократно проводились выскабливания полости матки. Гистологическое исследование соскоба эндометрия свидетельствовало о наличии гиперпластического процесса. Гормональное лечение с целью профилактики

рецидивов гиперплазии, как правило, не проводилось, или было неэффективным. На диспансерном учете пациентки не состояли.

В диссертационной работе К.Т. Исиной [4], защищенной в 1968 году, было выявлено, что при рецидивирующих гиперплазиях эндометрия наблюдаются такие же сопутствующие заболевания как у больных РТМ. После диагностических выскабливаний полости матки большинство менструальных циклов остаются ановуляторными. Автор предложила относить к предракам гиперпластические процессы эндометрия у женщин с эндокринно-обменными нарушениями.

Большинство больных РТМ были в постменопаузе. Возраст современных менопаузальных больных РТМ на 11 лет превышает возраст больных в 70-ые годы прошлого столетия. Больные с продолжительной менопаузой (от 19 до 33 лет) составили 52%, тогда как во второй группе не было ни одной пациентки с такой длительной менопаузой. В сравниваемых группах высокий процент женщин, у которых менопауза наступила в возрасте 50 лет и старше (76%-73%). По нашим данным, у здоровых женщин в 70-е годы прошлого столетия в среднем менопауза наступала в 47,3±1,5 лет [6]. В руководствах последних лет указано, что менопауза в среднем наступает в 50-52 года. У 44% менопаузальных больных РТМ первой группы, менопауза наступила в возрасте старше 52 лет. Известно, что у женщин, примерно, с 35 лет большинство менструальных циклов становятся ановуляторными, снижается возможность наступления беременности. После 40 лет все менструальные циклы ановуляторные, т.е. организм женщины испытывает влияние только эстрогенов. И чем длительнее продолжаются ановуляторные менструальные циклы, тем чаще возникают гормонозависимые новообразования репродуктивных органов. Эти данные позволяют заключить, что увеличение продолжительности жизни, позднее наступление менопаузы может быть одной из причин роста заболеваемости РТМ. Многие исследователи указывают, что для больных РТМ характерна недостаточность репродуктивной функции, проявляющаяся первичным и/или вторичным бесплодием, малочисленными родами [1,2,3]. Среди анализируемых нами больных в первой группе.

Таблица 1 - Клиническая характеристика больных раком тела матки, диагностированного в 2007-2011гг. (1гр.) в сравнении с больными 1965-1969гг. (2гр.)

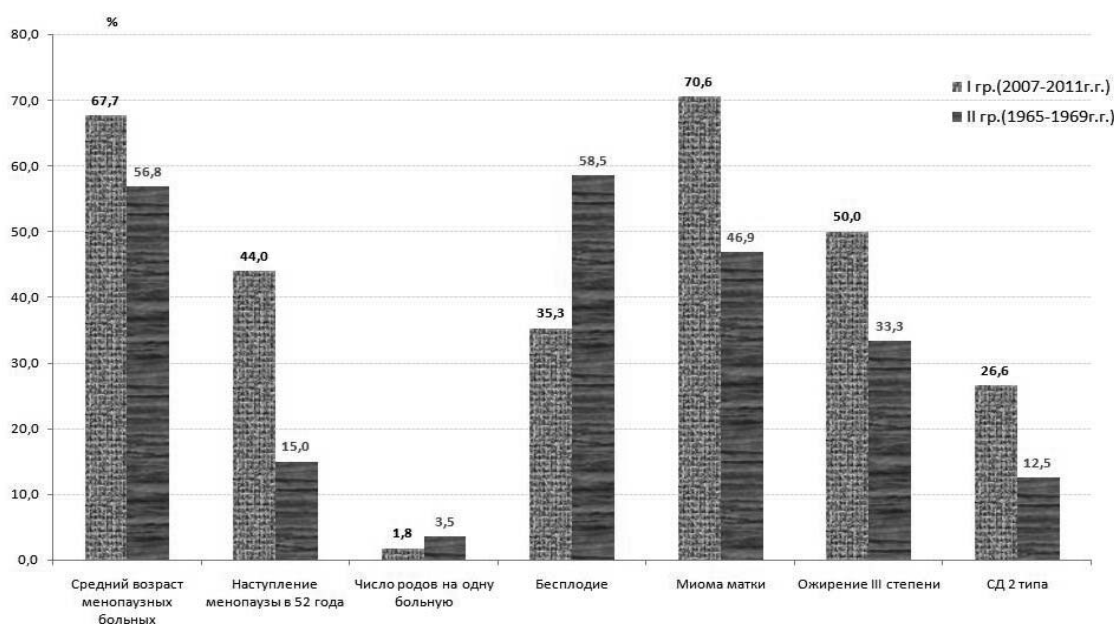
| Клинические данные                                  | 1 группа,<br>n=34 | 2 группа,<br>n=32 |
|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                     | Абс/ч %           | Абс/ч %           |
| РТМ до менопаузы                                    | 9 26,5±7,6        | 5 15,6±6,4        |
| РТМ в менопаузе                                     | 25 73,5±7,6       | 27 84,4±6,4       |
| Средний возраст доменопаузальных больных (лет)      | 47,3±1,5          | 52,0±2,9          |
| Больные с ДМК                                       | 8 88,9            | 5 100             |
| Средний возраст менопаузальных больных (лет)        | 67,7±2,1*         | 56,8±2,0          |
| Продолжительность менопаузы к моменту выявления РТМ |                   |                   |
| До 3 лет                                            | 5 20±5,8          | 9 33,3±6,1        |
| От 4 до 18 лет                                      | 7 28±8,9*         | 18 66,7±9,1       |
| 19-33 лет                                           | 13 52±9,9*        | -                 |
| Наступление менопаузы в 50 лет и старше             | 19 76±7,3         | 20 74±4,6         |
| Наступление менопаузы в 52 года                     | 11 44±8,5*        | 4 15±4,9          |
| Число беременностей на одну больную                 | 4,5±1,1           | 5,4±0,7           |

|                                                     |                         |                           |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Число родов на одну больную                         | 1,8±0,6*                | 3,5±0,5                   |
| Бесплодие                                           | 12 35,3±8,2*            | 18 58,5±8,7               |
| Миома матки                                         | 24 70,6±7,8*            | 15 46,9±8,8               |
| ИМТ кг/м2 из числа с ожирением 30 и выше 40 и более | 14 41,7±8,4<br>7 50±9,1 | 15 46,9±8,8<br>5 33,3±8,9 |
| СД 2 типа с клиническими проявлениями               | 9 26,6±7,5              | 4 12,5±5,8                |
| Артериальная гипертензия                            | 21 61,8±8,3             | 15 46,9±8,8               |

Примечание \* - p<0,05

была только одна женщина, страдавшая первичным бесплодием, во второй - одна девственница. Среди живущих половой жизнью и беременевших на одну пациентку приходилось 4,5±1,1 и 5,4±0,7 аборт и 1,8±0,6 - 3,5±0,5 родов. В последние годы число родов на одну больную РТМ уменьшилось почти в 2 раза. Снизилась также частота бесплодия - 58,5% в предыдущие годы до 35,3% у современных больных. Возможно, уменьшение числа родов и бесплодия объясняется использованием современными женщинами контрацептивных средств. Среди поступивших больных РТМ в ЦГКБ у 4-х выявлен ВМК, которая была введена от 10 до 23 лет тому назад. Эти данные свидетельствуют, с одной стороны, об отсутствии диспансерного наблюдения за женщинами с ВМК, с другой стороны, о возможности развития хронического эндометрита, снижении местного иммунитета. Последние исследования свидетельствуют, что причиной развития гиперпластических процессов эндометрия может быть нарушение тканевой рецепции, инфекционно-воспалительные изменения эндометрия, не только гиперэстрогения, но и гиперпролактинемия [9].

Представленные в таблице данные указывают на нередкое развитие РТМ в миоматозно-измененной матке и увеличение выявляемости миомы матки у пациенток РТМ в последние годы (с 46,9% до 70,6%). Клинические и данные ультразвукового исследования свидетельствуют о том, что миома обычно была небольших размеров, соответствующая величине матки при 6-7, 8-9 недельной беременности. Только у одной пациентки выявлена миома величиной, соответствующей 12-13 недельной беременности. Большинство больных не знали о наличии у них миомы матки, так как не обращались к гинекологам в течение многих лет. Исследования Е.И. Матасовой [5], А.С. Патрушевой [8], О.Л. Смахиной [10] подтверждают частое развитие РТМ в миоматозно-измененной матке. А.С. Патрушева проанализировала заключения морфологов по 347 больным РТМ, прооперированных в КазНИИОиР и ГОД (городской онкодиспансер) в 70-80 годы прошлого столетия и выявила, что у 172 (49,6%) женщин РТМ развился в миоматозной матке. При обследовании 350 женщин с бессимптомной миомой в пре- и постменопаузе с использованием аспирационной биопсии и морфологического исследования соскоба эндометрия у 213 (49,3%) из них установлено наличие железисто-кистозной гиперплазии и/или полипов эндометрия, атипическая гиперплазия у 9,4%, рак эндометрия у 3,3%. Автор показала, что относительный риск развития РТМ в миоматозной матке увеличивался в 43 раза у женщин с наличием ожирения, СД, артериальной гипертензии; в 12-20 раз при предшествующих гиперпластических процессах эндометрия. Были изданы рекомендации о необходимости обследования женщин группы риска по РТМ путем аспирационной биопсии. В настоящее время возможности трансвагинального ультразвукового исследования позволяют выявить по показателю М-ЭХО женщин,



Сравнительные клинические данные менопаузальных больных РТМ в 2007-11 гг. (I группа) и 1965-69 гг. (II группа)

которым необходимо произвести с диагностической целью выскабливание слизистой полости матки. Однако ни одна больная из анализированных современных 34 больных РТМ не подвергалась диспансерному наблюдению. Одна менопаузальная пациентка (8 лет менопауза) после появления кровянистых выделений по собственной инициативе провела УЗИ ОМТ, при котором врач установил показатель М-ЭХО 0,8см и выставил диагноз гиперплазия эндометрия, порекомендовал использовать дюфастон. Женщина безуспешно применяла дюфастон в течение 6 месяцев и только после усиления кровотечения поступила в стационар, где была выявлена аденокарцинома. Врач ультразвуковой диагностики не должен выставлять морфологический диагноз и тем более назначать лечение. При указанном показателе М-ЭХО, который в 2 раза превышает допустимый у женщины с менопаузой 8 лет, необходимо было рекомендовать выскабливание полости матки с диагностической целью. Полученные нами данные подтверждают высокую частоту ожирения в сравниваемых группах больных РТМ - 41,7-46,9%. Обращает внимание увеличение в последние годы числа женщин с ожирением третьей степени. Значительно возросла частота артериальной гипертензии, сахарного диабета 2 типа. Известно, что ожирение представляет наибольший интерес, как фактор риска развития данной патологии. Увеличение массы жировой ткани возникает в результате изменений множества факторов энергетического гомеостаза. В жировой ткани происходит ароматизация андростендиона в эстрон, а последний активно превращается в эстрадиол [11]. Кроме того, при ожирении снижается синтез в печени глобулина, связывающего половые стероиды, и протеинов, связывающих инсулиноподобный фактор роста (ИПФР). В результате этих изменений повышается биодоступность эстрадиола и ИПФР 1 типа, что приводит к значительному увеличению, пролиферативных процессов в эндометрии [12]. Следовательно, в настоящее время имеется возможность профилактики гиперпластических процессов путем нормализации метаболических нарушений, а также доклинической диагностики РТМ.

## Выводы

1. Рак тела матки в текущее время, так же как и 40 лет назад, в основном развивается в постменопаузе.
2. Возраст постменопаузальных больных раком тела матки в настоящее время на 11 лет старше, чем 40 лет назад, продолжительность менопаузы у 52% составляет более 19 лет, у 44% больных менопауза наступает старше 52 лет.
3. У больных доменопаузального возрастного периода развитию рака эндометрия предшествуют длительные, рецидивирующие маточные кровотечения, обусловленные гиперпластическими процессами эндометрия.
4. Современные больные РТМ чаще страдают ожирением 3 степени, артериальной гипертензией, сахарным диабетом 2 типа.
5. Особого внимания заслуживает факт увеличения развития РТМ в пре- и постменопаузе в миоматозно-измененной матке небольших размеров.
6. Необходимо усилить внимание гинекологов, терапевтов, эндокринологов, на женщин, страдающих ожирением, СД 2 типа, рецидивирующими гиперпластическими процессами эндометрия, с наличием миомы в пре и постменопаузе – как к группе риска по РТМ, требующим диспансеризации с использованием 2 раза в год трансвагинального УЗИ.

## Список литературы

1. Бохман Я.В. Руководство по онкогинекологии. М.: Медицина, 1989.- С. 275-296.
2. Вишневская Е.Е. Справочник по онкогинекологии.- Минск, 1980.
3. Гинекология по Эмилю Новаку.- М., 2002.-С. 665-700.
- Исина К.Т. Клинико-гормональная характеристика больных с предраками эндометрия. Автореф. дисс. к. м.н.- Алма-Ата, 1968.
3. Матасова Е.И. Диагностика и лечение сочетанных гиперпластических процессов мио-эндометрия: ... автореф. дис. к.м.н.к.- Алма-Ата, 1994.
4. Мезинова Н.Н. Функциональное состояние гипоталамико-надпочечниковой системы в процессестарения, при предраке и раке тела матки: ... автореф. дисс.

5. Мезинова Н.Н., Богданова А.Г., Кожаназарова Ю.С. Краевые и возрастные особенности эндокринной системы при раке матки и молочной железы.- Алма-Ата, 1977.-С. 38-59.
6. Патрушева А.С. Патогенетическое обоснование формирования групп риска. Диагностика, профилактика рака эндометрия у больных миомой матки: ... автореф. дисс. канд. мед. наук.- Алма-Ата, 1982.
7. Станевич И.В., Сидорова И. С. и др. Клинические, морфологические и молекулярные особенности гиперпластических заболеваний матки, практические выводы// Мат. 12 форума «Мать и дитя».- М., 2011.- С. 424.
8. Рак тела матки / Под редакцией О.Л. Смахиной.- Алматы, 1980.
9. Bulcz.PE. N. //Engl. Med. J.- 1994.- Vol. 330, №15.- P. 1062-1069.
10. Kaaks R., Lukanova A., Kuznez M.S. // Cancer Epidemiol. Bio- markers Prevent.- 2002.-Vol. 11.-P.1591-1543.

### Тұжырым

Зерттеудің максаты - жатыр денеа қатерлі ШӘШЦ саны жетеуің МҮмкін себептерін анықтау.

Әдттер мен материалдар: материал ретде ОЦКА - га 2007 -2011ж жатырдан кан кетумен тҮскен 34 наукас және жатыр денесің қатерлі ісігіне 1965 -1969ж ЦзОжРГЗИ ота жасалган 32 наукас алынды.

Зерттеу әдістері: клиникалық, зертханалық, статистикалық. Барлық наукастарда диагноз эндометрий жағындысын немесе алып тасалган ісігі морфологиялықзерттеумен верификацияланган. Семіздік дәрежесі ДСИ (ИМТ) - мен анықталды. ІІІ дәрежелі семіздік ДСИ 40 - тан жоғарыларда анықталды. Алынган мәліметтер статистикалық еңдеуден етті, салыстырмалы топтардың айырмашылықтары Стьюдент критериймен бағаланды. Керсетіштер айырмашылығы  $P < 0,05$  болганда дурыс деп есептелді.

Қазіргі кездегі менопаузадагы наукастар саны 40 жыл бурынғымен салыстырганда айтарлықтай жоғары екені нақтыланган. Қазіргі кездегі жатырдың қатерлі ісігімен ауыратын наукастарда, 40 жыл бурынғымен салыстырганда, менопауза кеш басталады және си-

рек босанады. Қатерлі Шк жиі миоматозды езгерген жатырда анықталады. Эндокринді - зат алмасу ауруларының (семіздік, кант диабеті 2 тҮрі, артериальды гипертензия, іііМі ІІІ дәрежелі семіздік) жоғарылауға тенденциясы байқалады.

Алынган мәліметтер агзаның картаюының және эндокринді - зат алмасу ауруларының, жатыр денеа қатерлі ШӘШЦ есуіне әсеріт дәлелдейді.

### Summary

The purpose of the study - to examine possible reasons for the increasing incidence of cancer of the corpus uteri.

Materials and Methods: The material included 34 patients with uterine body cancer presenting with uterine bleeding in the City Clinical Hospital in 2007-2011 and 32 patients with uterine body cancer who treated in Oncology and Radiology institute in 1965-1969 years.

Methods: This study used Clinical, laboratory, and statistical. All of patients whom verified diagnosis Cancer Uteri using of morphological investigation of scraping endometrium or the operative material. The degree of obesity was defined by BMI. Obesity is determined by third grade BMI greater than 40. The obtained data were statistically processed, significance of differences between investigated groups was assessed by Student criteria. The difference between the indices were considered significant at  $P < 0,05$ .

Our investigation showed the age of post-menopausal patients is more than 40 years ago. The point of menopause was started in women oldest 52 age. More often the cancer of uteri combined with myoma uteri. There is a tendency to an increase in endocrine-metabolic diseases: obesity, diabetes type 2, arterial hypertension. The third degree of obesity was prevalent.

According to our investigation the increasing of life period and the endocrine - metabolic disorders could be the cause of rise of uterine cancer.